

Mandatsnotiz

Mandant: Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, gelernter Elektrotechniker, wohnhaft in Münster-Hiltrup. Krankenversicherung: Vitalis BKK. Erstkontakt durch Ehefrau Teresa Lütke am 28.06.2026. Der Mandant ist seit Mai 2026 krankgeschrieben, hat starke Schmerzen im Becken und multiple Lungenmetastasen.

Medizinischer Hintergrund

Diagnose: metastasiertes alveoläres Weichteilsarkom, Erstdiagnose 2022, Operation und Strahlentherapie 2022, systemische Standardtherapie 2023 bis 2025, Progress im März 2026. Die Universitätsklinik Münster sieht keine kurative Option. Behandlungsziel ist Verlängerung des progressionsfreien Überlebens, Schmerzreduktion und Erhalt der Selbstständigkeit.

Beantragtes Arzneimittel: Lunazimerab, monoklonaler Antikörper, zugelassen als Arzneimittel für seltene Leiden. Dosierung nach Klinikplan: drei Dosen im Abstand von sechs Wochen. Kosten je Dosis laut Apothekenkalkulation: 500.000 EUR einschließlich Zubereitung und stationärer Überwachung.

Verfahrensstand

Antrag der Klinik vom 04.06.2026. MD-Stellungnahme vom 17.06.2026. Ablehnungsbescheid der Vitalis BKK vom 21.06.2026, Zugang am 24.06.2026. Widerspruch noch nicht eingelegt. Die Klinik reserviert einen Therapieslot für den 11.07.2026, fordert aber vorher eine Kostenzusage.

Auftrag

1. Widerspruch sofort einlegen.
2. Eilantrag zum Sozialgericht Münster vorbereiten.
3. Ärztliche Zusatzstellungnahme zu lebensbedrohlicher Erkrankung, fehlender Alternative und Nutzenwahrscheinlichkeit anfordern.
4. Kassenargumente Evidenz, Wirtschaftlichkeit und fehlende G-BA-Bewertung bearbeiten.

Antrag der Universitätsklinik Münster

Klinik für Hämatologie und Onkologie Prof. Dr. Mira Ebbinghaus, Oberärztin Sarkomzentrum Datum:
04.06.2026

Antrag auf Kostenübernahme

Für unseren Patienten Gregor Lütke beantragen wir die Kostenübernahme für eine Therapie mit Lunazimerab. Es handelt sich um ein Arzneimittel mit Zulassung für eine seltene Tumorentität. Der Patient leidet an einem metastasierten alveolären Weichteilsarkom mit Progress nach zwei systemischen Vorthérapien.

Bisheriger Verlauf

Datum	Maßnahme	Ergebnis
03.02.2022	Tumorresektion linker Oberschenkel	R1-Situation, Nachbestrahlung
04.2022 bis 06.2022	Strahlentherapie	lokale Kontrolle
08.2023	Lungenmetastasen	systemische Therapie begonnen
09.2023 bis 02.2025	Standardtherapie A	zunächst Stabilisierung, dann Progress
03.2025 bis 03.2026	Standardtherapie B	Progress in Lunge und Becken
29.05.2026	Tumorboard	Empfehlung Lunazimerab

Ärztliche Bewertung

Aus onkologischer Sicht besteht eine lebensbedrohliche Erkrankung mit kurzfristig relevanter Progressionsgefahr. Weitere leitliniengerechte Standardoptionen mit vergleichbarer Erfolgsaussicht stehen nicht zur Verfügung. Best Supportive Care ist möglich, würde aber voraussichtlich nur Symptomkontrolle, nicht Krankheitskontrolle erreichen.

Die vorliegenden Daten zu Lunazimerab zeigen bei einer Teilgruppe der Patienten mit vergleichbarer molekularer Signatur relevante Remissionen und eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. Beim Patienten liegt die Zielstruktur LZ-4 nach immunhistochemischer Untersuchung hoch exprimiert vor.

Wir bitten wegen des geplanten Therapiebeginns am 11.07.2026 um Entscheidung bis 05.07.2026.

Tumorboard und Nutzenblatt

Protokoll Sarkom-Tumorboard vom 29.05.2026

Anwesend: Onkologie, Radiologie, Pathologie, Strahlentherapie, Palliativmedizin, Studienkoordination, Psychoonkologie.

Fall: Gregor Lütke, 46 Jahre, metastasiertes alveoläres Weichteilsarkom. ECOG 1 bis 2, hohe Motivation, familiär eingebunden. Bildgebung vom 24.05.2026 zeigt Progress der pulmonalen Herde und neue osteolytische Läsion im rechten Os ilium. Schmerzen aktuell mit Oxycodon retard 2 mal 20 mg kontrolliert.

Diskutierte Optionen

Option	Nutzen	Einwand
Best Supportive Care	Symptomkontrolle, geringe Toxizität	keine Krankheitskontrolle
Re-Challenge Standardtherapie A	ambulant verfügbar	Progress unter gleicher Substanz dokumentiert
Phase-I-Studie Hamburg	wissenschaftlich interessant	Einschluss frühestens September, Reisefähigkeit fraglich
Lunazimerab	zielgerichtete Therapie, Orphan-Drug-Zulassung	extrem hohe Kosten, begrenzte Daten

Ergebnis

Das Tumorboard empfiehlt Lunazimerab. Die Empfehlung beruht auf fehlenden Standardalternativen, Zielstruktur LZ-4, gutem Allgemeinzustand und realistischer Aussicht auf klinisch relevante Krankheitskontrolle. Palliativmedizin soll parallel eingebunden bleiben.

Nutzenblatt für die Kasse

Die Klinik schätzt die realistische Nutzenerwartung nicht als Heilung, sondern als Verlängerung der krankheitskontrollierten Zeit um etwa 18 bis 24 Monate bei Ansprechen. Die Aussage beruht auf der Studie LUNA-SAR-02, Registerdaten aus Frankreich und dem molekularen Befund des Patienten. Die Klinik räumt ein, dass es keine randomisierte Phase-III-Studie gibt.

Beweisprobleme

1. Der Patient ist schwer krank, aber nicht unmittelbar moribund.
2. Die Kosten sind außergewöhnlich hoch.
3. Die Nutzenlage ist nicht leer, aber unsicher.
4. Der MD stellt auf fehlende vergleichende Evidenz ab.
5. Das Gericht muss im Eilverfahren medizinische Plausibilität und Folgenabwägung verbinden.

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe Gutachter: Dr. med. Peter Niermann, Facharzt für Innere Medizin
Datum: 17.06.2026

Auftrag

Prüfung der beantragten Kostenübernahme für Lunazimerab bei metastasiertem alveolärem Weichteilsarkom.

Zusammenfassung

Beim Versicherten liegt eine schwerwiegende onkologische Erkrankung vor. Die bisherige Therapie ist ausgeschöpft. Gleichwohl kann die beantragte Arzneimitteltherapie aus sozialmedizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Begründung

Die vorgelegten Unterlagen zeigen eine Orphan-Drug-Zulassung, aber keine abgeschlossene Nutzenbewertung mit tragfähiger Aussage zur zweckmäßigen Vergleichstherapie. Die Klinik verweist auf Phase-II-Daten und Registerdaten. Diese Daten sind hypothesengenerierend und erlauben keine belastbare Aussage, dass beim Versicherten eine Überlebensverlängerung um zwei Jahre zu erwarten ist.

Best Supportive Care und eine Studienteilnahme sind nicht ausgeschlossen. Die Kosten von 500.000 EUR je Dosis stehen in einem besonders auffälligen Verhältnis zur unsicheren Nutzenlage. Eine Leistungspflicht kann aus den vorgelegten Unterlagen nicht abgeleitet werden.

Empfehlung

Ablehnung der Kostenübernahme. Es sollte eine erneute Vorstellung in einer Studienambulanz geprüft werden. Eine palliativmedizinische Mitbehandlung wird empfohlen.

Schwächen der Stellungnahme

Der Gutachter hat den Patienten nicht untersucht. Die Stellungnahme setzt sich nicht mit der konkreten LZ-4-Expression auseinander. Sie bewertet die Reisefähigkeit nach Hamburg nicht. Der Begriff "Best Supportive Care" bleibt ohne konkrete Darstellung, welche Lebenszeit und Lebensqualität damit realistischerweise erreichbar sind.

Ablehnungsbescheid der Vitalis BKK

Absender: Vitalis BKK, Leistungszentrum Arzneimittel, Dortmund Datum: 21.06.2026 Zugang: 24.06.2026

Entscheidung

Sehr geehrter Herr Lütke,

die Kostenübernahme für das Arzneimittel Lunazimerab wird abgelehnt.

Begründung

Die beantragte Therapie ist außergewöhnlich kostenintensiv. Nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes liegt keine hinreichend gesicherte Datenlage vor, die einen individuellen Nutzen in dem von der Klinik angenommenen Umfang belegt. Die vorhandenen Studien sind nicht ausreichend vergleichend. Eine Therapie mit Best Supportive Care und die Prüfung einer Studienteilnahme sind möglich.

Die gesetzliche Krankenversicherung darf nur Leistungen erbringen, die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Bei ungesicherter Nutzenlage und Kosten von etwa 1.500.000 EUR für drei Dosen ist die beantragte Versorgung nicht wirtschaftlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Telefonnotiz Ehefrau

Frau Teresa Lütke rief am 25.06.2026 bei der Kasse an. Eine Sachbearbeiterin sagte nach ihrer Erinnerung: "Bei solchen Summen entscheidet am Ende sowieso das Gericht." Ein schriftliches Gesprächsprotokoll der Kasse liegt nicht vor.

Widerspruch und Eilantrag

Widerspruch an die Vitalis BKK

Gegen den Bescheid vom 21.06.2026 wird Widerspruch eingelegt.

Der Widerspruch wird damit begründet, dass die Ablehnung die konkrete medizinische Situation nicht ausreichend würdigt. Der Versicherte leidet an einer lebensbedrohlichen, seltenen Tumorerkrankung. Standardtherapien sind ausgeschöpft. Die behandelnde Universitätsklinik hat eine individuelle Zielstruktur nachgewiesen und die Therapie im interdisziplinären Tumorboard empfohlen.

Die Kasse stützt sich auf eine MD-Stellungnahme nach Aktenlage. Diese setzt sich nicht ausreichend mit dem molekularen Befund, der Reisefähigkeit für eine Studie und dem konkreten Zeitfenster des geplanten Therapiebeginns auseinander.

Entwurf Eilantrag Sozialgericht Münster

Antrag:

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller vorläufig die Versorgung mit Lunazimerab nach ärztlicher Verordnung der Universitätsklinik Münster für zunächst drei Dosen zu gewähren.

Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen 48 Stunden eine persönliche fachonkologische Begutachtung unter Einbeziehung des Tumorboards zu veranlassen und bis dahin die Therapiereservierung nicht durch Untätigkeit vereiteln zu lassen.

Anordnungsgrund

Der Therapieslot ist auf den 11.07.2026 reserviert. Nach Auskunft der Klinik verschlechtert eine weitere Verzögerung die Chance auf Krankheitskontrolle. Eine spätere Hauptsacheentscheidung käme für den Antragsteller voraussichtlich zu spät.

Beweisangebote

1. Ärztliche Stellungnahme Prof. Dr. Ebbinghaus.
2. Tumorboardprotokoll vom 29.05.2026.
3. Molekularpathologischer Befund LZ-4.
4. Anhörung des behandelnden Onkologen.
5. Hilfsweise gerichtliches Sachverständigengutachten mit Fristsetzung.

Gerichtliche Beweisfragen und Vergleichsfenster

Entwurf richterlicher Hinweis

Das Gericht beabsichtigt, kurzfristig eine ergänzende Stellungnahme der Universitätsklinik Münster einzuholen. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht die vollständige Hauptsache vorweggenommen werden soll, jedoch der drohende Verlust einer realistischen Behandlungschance zu berücksichtigen sein kann.

Beweisfragen an die Klinik

1. Welche Standardtherapien sind beim Antragsteller ausgeschöpft und aus welchem Grund?
2. Welche konkrete Zielstruktur begründet die Auswahl von Lunazimerab?
3. Welche Daten tragen die Erwartung einer klinisch relevanten Krankheitskontrolle?
4. Welche Folgen hat eine Verzögerung des Therapiebeginns um vier, acht oder zwölf Wochen?
5. Welche objektiven Abbruchkriterien können nach der ersten oder zweiten Dosis festgelegt werden?

Vergleichsfenster

Eine Vergleichslösung könnte eine erste Dosis mit engmaschigem Monitoring und erneuter Entscheidung über Dosis zwei und drei vorsehen. Die Kasse würde damit keine unbefristete Kostenzusage erteilen, der Versicherte verlöre aber nicht das aktuelle Behandlungsfenster. Streitpunkt bleibt, ob eine solche Aufteilung medizinisch sinnvoll und rechtlich zulässig ist.

Kostenvoranschlag der Krankenhausapotheke

Universitätsklinikum Münster Apotheke und Arzneimittelherstellung Vorgang: Gregor Lütke, Geburtsdatum 03.02.1980 Erstellt am: 21.06.2026

Arzneimittel

Lunazimerab 500 mg Infusionskonzentrat, Sonderbeschaffung über Herstellerprogramm "LZM-Access EU". Das Arzneimittel ist für die beantragte Indikation nicht als Standardtherapie im deutschen Versorgungspfad hinterlegt. Die Klinik sieht nach Tumorboardbeschluss dennoch ein enges Zeitfenster, weil der Patient nach der letzten Bildgebung vom 10.06.2026 eine deutliche Progression in Lunge und Becken zeigt.

Kosten

Position	Menge	Einzelbetrag	Gesamt
Wirkstoff Lunazimerab 500 mg	1 Dosis	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Einfuhr, Kühlkette, Sicherheitslogistik	1 Vorgang	8.920,00 EUR	8.920,00 EUR
Sterile Aufbereitung und Plausibilitätsprüfung	1 Vorgang	1.480,00 EUR	1.480,00 EUR
Begleitmedikation und Notfallset	1 Gabe	1.265,00 EUR	1.265,00 EUR
Summe erste Gabe			511.665,00 EUR

Für den beantragten Behandlungszyklus sind drei Gaben im Abstand von jeweils 28 Tagen vorgesehen. Die Klinik kalkuliert für drei Gaben einschließlich Logistik und Aufbereitung 1.534.995,00 EUR.

Liefer- und Verfallsrisiko

Der Hersteller reserviert die erste Dosis bis 05.07.2026. Danach ist eine neue Freigabe erforderlich. Eine angebrochene Dosis kann nicht weiterverwendet werden. Die Lieferung muss 72 Stunden vor Applikation beauftragt sein. Eine Finanzierung nachträglich nach Gabe ist aus Sicht der Apotheke nur möglich, wenn vorher eine Kostenzusage, ein gerichtlicher Beschluss oder eine schriftliche Übernahmeerklärung vorliegt.

Fachliche Rückfrage der Apotheke

Die Apotheke bittet die behandelnde Klinik um schriftliche Bestätigung, ob die erste Gabe ambulant in der Tagesklinik oder stationär erfolgen soll. Bei stationärer Gabe sind gesonderte DRG- und NUB-Fragen zu klären. Bei ambulanter Gabe liegt das Kostenrisiko unmittelbarer bei der beantragten Einzelkostenübernahme.

Pflege- und Schmerzprotokoll

Gregor Lütke

geführt von: Nora Lütke, Ehefrau

Zeitraum: 17.06.2026 bis 23.06.2026

17.06.2026

Morgens Atemnot nach Treppe vom Schlafzimmer ins Erdgeschoss. Pause auf der siebten Stufe. Schmerz rechte Hüfte 6 von 10. Novalgin genommen. Spaziergang zur Ecke nach 80 Metern abgebrochen.

18.06.2026

Nachts zweimal aufgewacht wegen Druck im Brustkorb. Kein Fieber. Appetit gering. Telefonat mit Klinik: Bitte Schmerzprotokoll weiterführen. Gregor sagt, er wolle die Entscheidung der Kasse nicht "aussitzen", weil er merkt, dass die Luft schlechter wird.

19.06.2026

Hausarzt Dr. Kannenberg daheim. Sauerstoffsättigung nach Gang durch Flur 91 Prozent, in Ruhe 95 Prozent. Oxycodon niedrig dosiert besprochen, Gregor zögert wegen Müdigkeit. Arzt sagt, Therapiefenster solle nicht ohne medizinischen Grund verstreichen.

20.06.2026

Besuch der Schwester. Gregor konnte 35 Minuten am Tisch sitzen, danach Liegen. Schmerz Becken 7 von 10. Einmal Übelkeit. Keine Einweisung, weil Termin in Münster erwartet wird.

21.06.2026

Vormittags besser. 120 Meter bis zum Parkplatz geschafft, aber Rückweg mit zwei Pausen. Abends wieder Atemnot. Gregor fragt nach Patientenverfügung, sagt aber gleichzeitig, er wolle die beantragte Behandlung versuchen.

22.06.2026

Brief der Kasse erneut gelesen. Gregor sehr angespannt. Kein Spaziergang. Schmerzmittel nach Plan, zusätzlich Wärmekissen. Telefonat mit Sozialdienst: Eilantrag soll vorbereitet werden.

23.06.2026

E-Mail der Klinik mit Termin 01.07.2026 erhalten. Gregor erleichtert, zugleich Sorge wegen Kosten. Schmerz rechte Hüfte 5 bis 8 von 10 über den Tag. Atemnot beim Duschen. Nora organisiert Duschhocker.

Von	"Prof. Dr. Amelie Vorrath" <onkologie@ukm.example.invalid>
An	Gregor Luetke <gregor.luetke@example.invalid>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 16:28:52 +0200
Betreff	Termin 01.07.2026 und Unterlagen zur beantragten Therapie

Sehr geehrter Herr L■■■tke,

wir haben f■■■r Sie am 01.07.2026 um 08:15 Uhr einen Termin in der onkologischen Tagesklinik reserviert. Der Termin dient zun■■■chst der klinischen Untersuchung, Laborabnahme und Aufkl■■■rung. Die Gabe von Lunazimerab kann an diesem Tag nur erfolgen, wenn bis dahin eine belastbare Kostenkl■■■rung vorliegt.

Medizinisch ist das Zeitfenster eng. Die Bildgebung vom 10.06.2026 zeigt eine zunehmende Belastung der rechten Lunge und eine neue L■■■sion am Beckenkamm. Ihre Atemnot bei Belastung und die Schmerzspitzen passen dazu. Wir sehen keine kurative Situation. Ziel ist Krankheitskontrolle und Erhalt der Gehstrecke. Das Tumorboard hat wegen Ihrer bisherigen Therapien und der seltenen Tumorbilogie die beantragte Behandlung empfohlen.

Bitte bringen Sie mit:

- aktuellen Medikamentenplan,
- Schmerzprotokoll der letzten sieben Tage,
- Entlassungsbrief der Strahlentherapie aus April 2026,
- Bescheid der Krankenkasse und Schreiben des Medizinischen Dienstes,
- Kontaktdaten einer Vertrauensperson f■■■r die Aufkl■■■rung.

Wenn die Finanzierung bis 01.07.2026 offen bleibt, m■■■ssen wir den Termin in einen Beratungstermin umwandeln. Wir dokumentieren dann, dass die Behandlung nicht aus medizinischen, sondern aus Kostenkl■■■rungsgr■■■nden nicht begonnen wurde.

Mit freundlichen Gr■■■■■■en

Prof. Dr. Amelie Vorrath
Klinik f■■■r H■■■matologie und Onkologie
Universit■■■tsklinikum M■■■nster

Datei: 07_therapie_kostenmatrix.csv

dosis	geplanter_tag	kosten_arznei	kosten_ueberwachung	klinisches_ziel	streitpunkt
1	2026-07-11	500000.00	18200.00	initiale Krankheit skontrolle	Eilbeduerftigkeit und Kosten
2	2026-08-22	500000.00	16400.00	Stabilisierung pulmonaler Herde	Nutzenprognose unsicher
3	2026-10-03	500000.00	16400.00	Verlaengerung progressionsfreie Zeit	Folgenabwaegung gegen Wirtschaftlichkeit